Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Tonsillektomie

Entfernung der Gaumenmandeln (vollständig oder teilweise)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Geplante Technik:

- ☐ Konventionelle Präparation (Kalttechnik)
- ☐ Elektrokoagulation (Elektrokauter) ☐ Radiofrequenz / Coblation
- ☐ Tonsillotomie (Teilentfernung)

Zusätzliche Eingriffe in derselben Sitzung: ☐ Adenotomie ☐ Paukenröhrchen ☐ Keine _____

Grund für die Operation (vom Arzt auszufüllen):

- ☐ Wiederkehrende Mandelentzündung
- ☐ Schlafbezogene Atmungsstörung / Schnarchen
- ☐ Peritonsillarabszess ☐ Einseitige Vergrößerung / Gewebediagnose

_____

Sonstiges / Anmerkungen: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Die Gaumenmandeln (Tonsillen) sind lymphatisches Gewebe und Teil des körpereigenen Abwehrsystems; sie liegen auf beiden Seiten des Rachens oberhalb des Zungengrunds. Nach Entfernung der Gaumenmandeln arbeitet das Abwehrsystem über die übrigen lymphatischen Gewebe in Mund und Rachen weiter; dass die Operation die Immunabwehr schwächt, wurde nicht nachgewiesen.

Eine Tonsillektomie wird am häufigsten empfohlen bei: **Mandelentzündungen**, die mehrmals im Jahr auftreten und zu Fehlzeiten in Schule oder Beruf führen; vergrößerten Mandeln, die **Schnarchen und Atemaussetzer im Schlaf** verursachen; einem **Abszess um die Mandel (Peritonsillarabszess)**; oder einer einseitigen Vergrößerung einer Mandel bzw. einer verdächtigen Gewebeveränderung. Bei manchen Patientinnen und Patienten können auch Mundgeruch und Mandelsteine Gründe sein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Ziel der Operation ist es, diese Beschwerden zu beseitigen oder zu verringern. Ihr Arzt wird Ihnen gesondert erklären, warum die Operation für Sie oder Ihr Kind empfohlen wurde.

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation wird in Vollnarkose im Operationssaal durch den Mund durchgeführt; **es gibt keine Schnitte oder Narben von außen.**

1. **Vorbereitung:** Nach Einleitung der Narkose wird ein spezielles Instrument eingesetzt, das den Mund offen hält und die Zunge schützt.
2. **Entfernung der Gaumenmandeln:** Jede Mandel wird zusammen mit ihrer umgebenden Kapsel von der darunterliegenden Muskelschicht gelöst und entfernt. Je nach geplanter Technik geschieht dies mit Schere und Präparierinstrumenten (Kalttechnik), mit Elektrokauter oder mit Radiofrequenz-/Coblation-Geräten.
3. **Teilentfernung (Tonsillotomie):** Bei geeigneten Patientinnen und Patienten, vor allem bei kleinen Kindern mit Atemproblemen im Schlaf, kann nur der vergrößerte Teil der Mandel entfernt und eine dünne Schicht belassen werden. Diese Methode kann weniger Schmerzen und ein geringeres Blutungsrisiko mit sich bringen; das verbleibende Gewebe kann jedoch nachwachsen oder sich entzünden.
4. **Blutstillung:** Blutungen in den Mandelbetten werden sorgfältig mit Nähten, Unterbindungen oder Kauterisation gestillt. Die Mandelbetten werden in der Regel offen gelassen und heilen von selbst ab.
5. **Zusätzliche Eingriffe:** Falls geplant, werden in derselben Narkose die Rachenmandel entfernt (Adenotomie) oder Paukenröhrchen eingesetzt; für diese Eingriffe werden gesonderte Aufklärungsbögen ausgefüllt.
6. **Aufwachen und Überwachung:** Nach der Operation wird die Patientin / der Patient im Aufwachraum und anschließend auf der Station hinsichtlich Blutung, Atmung und Flüssigkeitsaufnahme überwacht.

Hält der Arzt es für notwendig, werden die entfernten Mandeln zur feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung eingesandt.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Vollnarkose	Etwa 30–45 Minuten (ohne Narkosezeit)	In der Regel eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Eine deutliche Verringerung wiederkehrender Mandelentzündungen und der damit verbundenen Fieberschübe, Halsschmerzen, Antibiotikaeinnahmen und Fehlzeiten in Schule oder Beruf
- Weniger Schnarchen und weniger Atemaussetzer im Schlaf; besserer Schlaf sowie verbesserte Aufmerksamkeit und besseres Verhalten am Tag
- Vorbeugung gegen wiederkehrende Peritonsillarabszesse
- Falls erforderlich, eine gesicherte Diagnose durch die feingewebliche Untersuchung des Gewebes

Bei sorgfältig ausgewählten Patientinnen und Patienten bessern sich wiederkehrende Halsinfektionen und schlafbezogene Atmungsstörungen weitgehend. Gelegentliche Rachenentzündungen (Pharyngitis) können auch nach der Operation noch auftreten, sind aber meist seltener und milder. Hat die Schlafapnoe zusätzlich andere Ursachen – etwa Übergewicht, die Gesichtsform oder eine behinderte Nasenatmung –, verschwinden die Beschwerden möglicherweise nicht vollständig, und eine weitere Behandlung kann notwendig sein.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Abwartendes Beobachten:** Erfüllt die Häufigkeit der Entzündungen nicht die Kriterien für eine Operation oder sind die Beschwerden gering, kann ein Abwarten mit regelmäßigen Kontrollen angemessen sein. Bei Kindern können Mandelentzündungen mit zunehmendem Alter seltener werden.
- **Antibiotika und unterstützende Behandlung:** Jede Infektionsepisode wird weiterhin mit Medikamenten behandelt; dies verhindert jedoch keine weiteren Episoden.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Teilentfernung (Tonsillotomie):** Kann bei geeigneten Patientinnen und Patienten anstelle der vollständigen Entfernung erwogen werden (siehe oben).
- **Andere Möglichkeiten bei Schlafapnoe:** Gewichtsabnahme, Behandlung einer behinderten Nasenatmung, kortisonhaltige Nasensprays oder ein Überdruckbeatmungsgerät (CPAP) im Schlaf.

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Ohne Operation können wiederkehrende Mandelentzündungen, Fieber, Antibiotikaeinnahmen und Fehlzeiten in Schule oder Beruf fortbestehen. Selten kann sich ein Abszess um die Mandel bilden oder eine Infektion auf das Gewebe des Halses übergreifen. Bleibt eine durch vergrößerte Mandeln verursachte Schlafapnoe unbehandelt, kann sie – vor allem bei Kindern – zu verzögertem Wachstum und verzögerter Entwicklung, Aufmerksamkeits- und Verhaltensproblemen, Einnässen und langfristig zu einer Belastung von Herz und Lunge führen. In verdächtigen Situationen wie einer einseitigen Vergrößerung kann der Verzicht auf die Operation eine gesicherte Diagnose verzögern.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen (insbesondere Blutungs- und Gerinnungstests) und gegebenenfalls weitere notwendige Untersuchungen durchgeführt, und Sie werden vom Narkosearzt untersucht.
- Bitte teilen Sie uns mit, wenn bei Ihnen oder in Ihrer Familie eine Neigung zu Blutungen, häufiges Nasenbluten, starke oder verlängerte Monatsblutungen, eine nicht stillbare Blutung nach einer Zahnentfernung oder eine bekannte Blutgerinnungsstörung vorliegt.
- **6 Stunden** vor der Operation dürfen keine feste Nahrung und keine Milch zu sich genommen werden; für klare Flüssigkeiten gilt die vom Narkosearzt angegebene Zeit.
- Bitte teilen Sie uns eine akute Mandelentzündung, eine fieberhafte Erkrankung oder eine Grippe in den 2–3 Wochen vor der Operation mit; die Operation muss dann möglicherweise verschoben werden.
- Informieren Sie Ihren Arzt über lockere Zähne oder Zahnprothesen.
- Wenn Sie aus dem Ausland anreisen, empfehlen wir, nach der Operation **mindestens 10–14 Tage** in erreichbarer Nähe Ihres Arztes und des Krankenhauses zu bleiben (wegen des Risikos einer Nachblutung).
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Operationstag	Beim Aufwachen haben Sie Halsschmerzen; diese werden mit Schmerzmitteln behandelt. Sobald eine eventuelle Übelkeit abgeklungen ist, wird Wasser gegeben, danach kühle oder lauwarme Getränke und weiche Speisen. Sie bleiben über Nacht im Krankenhaus und werden hinsichtlich Blutung, Atmung und Flüssigkeitsaufnahme überwacht.
1.–4. Tag	

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	Halsschmerzen und in die Ohren ausstrahlende Schmerzen sind deutlich spürbar. Auf den Mandelbetten bildet sich ein **weißlich-gelblicher Belag**; dies ist ein normaler Teil der Heilung und keine Infektion. Mundgeruch und leicht erhöhte Temperatur können auftreten. **Die regelmäßige Einnahme der Schmerzmittel und reichliches Trinken** sind das Wichtigste.
5.–10. Tag	Der weiße Belag beginnt sich zu lösen. Die Schmerzen können in dieser Zeit manchmal wieder zunehmen. **In dieser Phase ist das Risiko einer Nachblutung am höchsten**; vermeiden Sie anstrengende körperliche Betätigung, heiße Bäder/Sauna und harte Speisen, und suchen Sie bei jedem Anzeichen einer Blutung sofort ärztliche Hilfe.
10.–14. Tag	Die Schmerzen lassen deutlich nach, und die normale Ernährung wird wieder aufgenommen. Die meisten Kinder gehen innerhalb von 10–14 Tagen wieder zur Schule, Erwachsene wieder zur Arbeit. Sport und schwere körperliche Tätigkeit sind in der Regel nach etwa 2–3 Wochen erlaubt.
3.–6. Woche	Die Mandelbetten heilen vollständig ab. Es erfolgt eine Kontrolluntersuchung; wurde eine feingewebliche Untersuchung durchgeführt, wird das Ergebnis besprochen.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Halsschmerzen (dauern meist 7–14 Tage; bei Erwachsenen stärker ausgeprägt als bei Kindern)
- In die Ohren ausstrahlende Schmerzen (fortgeleiteter Schmerz; sie bedeuten nicht, dass ein Problem im Ohr vorliegt)
- Schluckbeschwerden und Appetitlosigkeit; etwas Gewichtsverlust in den ersten Tagen
- Weißlich-gelber Wundbelag auf den Mandelbetten und Mundgeruch
- Leicht erhöhte Temperatur (in den ersten Tagen), Übelkeit und Erbrechen durch die Narkose
- Vorübergehende Schwellung der Zunge und des Zäpfchens

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Blutung nach der Operation (Nachblutung)** — Tritt bei etwa **2–5 von 100** Patientinnen und Patienten auf, am häufigsten **5–10 Tage nach der Operation**, wenn sich der Wundbelag löst. Bei Erwachsenen ist sie etwas häufiger als bei Kindern. Die meisten Nachblutungen sind gering und kommen durch Beobachtung, Eis, eine Behandlung im Mund oder einen einfachen Eingriff zum Stillstand.
- **Erneute Operation wegen Blutung** — Bei etwa **1–3 von 100** Patientinnen und Patienten kann **eine erneute Operation in Vollnarkose** zur Blutstillung notwendig werden. Der Krankenhausaufenthalt kann sich verlängern.
- **Zu geringe Flüssigkeitsaufnahme und Austrocknung (Dehydratation)** — Wird wegen der Schmerzen nicht genug getrunken, können besonders bei kleinen Kindern Schwäche und verminderte Urinausscheidung auftreten; manchmal ist eine Krankenhausaufnahme zur Flüssigkeitsgabe über die Vene (Infusion) notwendig.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Gelegentliche Beschwerden

- **Bluttransfusion** — Geht bei einer Blutung viel Blut verloren, kann eine Bluttransfusion notwendig werden; dies kommt bei **weit weniger als 1 von 100** Patientinnen und Patienten vor.
- **Geschmacksstörung und Taubheitsgefühl der Zunge** — Da die Zunge während der Operation durch das Instrument unter Druck gehalten wird, können eine Geschmacksveränderung oder ein Taubheitsgefühl der Zunge auftreten; dies bessert sich meist innerhalb weniger Wochen, kann aber selten Monate anhalten oder dauerhaft sein.
- **Verletzung von Zähnen, Lippen und Zunge** — Durch den Druck des Instruments, das den Mund offen hält, kann ein Zahn abbrechen (besonders ein lockerer oder kariöser Zahn), oder es können eine kleine Verbrennung, eine Wunde oder eine Schwellung an Lippen oder Zunge entstehen.
- **Infektion** — In den Mandelbetten oder am Hals kann sich eine Infektion entwickeln; sie wird in der Regel mit Antibiotika behandelt.
- **Vorübergehend näselnde Sprache** — Da die Beweglichkeit des Gaumens durch die Schmerzen eingeschränkt ist, kann beim Sprechen vorübergehend Luft durch die Nase entweichen; dies bildet sich meist innerhalb weniger Wochen zurück.
- **Nachwachsen nach Tonsillotomie** — Wurde eine Teilentfernung durchgeführt, kann das verbliebene Mandelgewebe nachwachsen oder sich entzünden (bei etwa **1–6 von 100**); selten kann dann eine vollständige Tonsillektomie notwendig werden.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Schwere Blutung und ihre Folgen** — Selten kann eine Blutung stark und rasch verlaufen. In diesem Fall können **eine Notoperation, eine Bluttransfusion** und sehr selten zusätzliche Eingriffe an den Blutgefäßen des Halses notwendig werden. Ein starker Blutverlust oder Blut, das in die Atemwege gelangt, kann zu schwerwiegenden Folgen wie **Atemversagen, der Notwendigkeit einer Behandlung auf der Intensivstation** und daraus resultierenden bleibenden Schäden führen.
- **Lebensbedrohliche Komplikationen und Tod** — Todesfälle im Zusammenhang mit einer Tonsillektomie sind äußerst selten; in der medizinischen Fachliteratur werden sie mit etwa **1 auf 15.000–35.000 Operationen** angegeben. Die häufigsten Ursachen sind schwere Blutungen und Atemprobleme. Kleine Kinder mit schwerer Schlafapnoe haben nach der Operation ein höheres Risiko für Atemprobleme; diese Patientinnen und Patienten werden daher engmaschiger überwacht.
- **Dauerhaft näselnde Sprache / Rückfluss von Flüssigkeiten durch die Nase (velopharyngeale Insuffizienz)** — Sehr selten; vor allem bei Menschen mit einer verdeckten Gaumenspalte. Eine logopädische Behandlung (Sprachtherapie) oder selten eine Korrekturoperation kann notwendig sein.
- **Verschiebung der Halswirbel (Grisel-Syndrom), Ausbreitung einer Infektion in Hals oder Brustraum** — Sehr seltene Erkrankungen, die bei frühzeitiger Erkennung behandelbar sind. Sie können sich durch stetig zunehmende Nackenschmerzen, die Unfähigkeit, den Kopf zu drehen, hohes Fieber und Unfähigkeit zu schlucken äußern. Treten sie auf, sind eine Krankenhausaufnahme, intravenöse Antibiotika (über die Vene) und bei Bedarf eine operative Entlastung (Drainage) erforderlich; bei verzögerter Behandlung können bleibende Probleme am Hals entstehen, oder eine sich ausbreitende Infektion kann lebensbedrohlich werden.
- **Vernarbung und Verengung von Rachen und Gaumen** — Sehr selten kann sich während der Heilung übermäßiges Narbengewebe bilden, das Rachen oder Gaumen verengt und zu Schluck- oder Sprechstörungen führt.
- **Schmerzen oder Ausrenkung im Kiefergelenk** — Tritt sehr selten infolge des langen Offenhaltens des Mundes auf.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Frisches, hellrotes Blut** aus dem Mund, Ausspucken oder Erbrechen von Blut – **auch nur wenige Tropfen** –: Suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf. Bei einer Blutung beugen Sie den Kopf nach vorne und spucken Sie das Blut aus, statt es zu schlucken; Sie können mit kaltem Wasser gurgeln.
- Bei Kindern: **häufiges Schlucken**, Blässe, Schwäche, lässt sich nur schwer aufwecken (kann ein Zeichen für verschlucktes Blut sein)
- **Atembeschwerden**, deutliche Atemaussetzer im Schlaf, geräuschvolle Atmung
- **Fieber über 38,5 °C** oder Schmerzen, die trotz Schmerzmitteln nicht nachlassen oder immer stärker werden
- Trinkt gar nichts mehr, seit 8 Stunden kein Urin, ungewöhnliche Schläfrigkeit (Zeichen von Flüssigkeitsmangel)
- Stetig zunehmende Nackenschmerzen, Unfähigkeit, den Kopf zu drehen, Schwellung am Hals

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Verwenden Sie gegen Schmerzen nur **die von Ihrem Arzt empfohlenen Schmerzmittel** in der empfohlenen Dosierung und in den empfohlenen Abständen und **nehmen Sie sie regelmäßig ein**. Aspirin und andere nicht von Ihrem Arzt empfohlene Schmerzmittel können das Blutungsrisiko erhöhen; nehmen Sie keine Medikamente eigenmächtig zusätzlich ein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Reichlich zu trinken** ist die wichtigste Regel. Geeignet sind kühles oder lauwarmes Wasser, Ayran (Joghurtgetränk), Kompott, Speiseeis, Milchpudding, Joghurt und Pürees. Meiden Sie sehr heiße, saure, scharf gewürzte und harte/knusprige Speisen (Chips, Cracker, Toast) für etwa **2 Wochen**.
- Vermeiden Sie in den ersten 2 Wochen anstrengende körperliche Betätigung, heiße Bäder, Sauna und längere Aufenthalte in der Sonne.
- Sie können weiterhin Ihre Zähne putzen; vermeiden Sie jeden harten Kontakt mit dem Rachen.
- Wir empfehlen, Ihren Rückflug ins Ausland zu verschieben, bis das Risiko einer Nachblutung vorüber ist (in der Regel **10–14 Tage nach der Operation**). Müssen Sie früher fliegen, besprechen Sie die Risiken mit Ihrem Arzt.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.

☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.

☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.

☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.

☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.

☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.

☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.

☐ Mir wurde verständlich erklärt, dass **eine Nachblutung auftreten kann**, und zwar innerhalb der ersten 2 Wochen nach der Operation, besonders am 5.–10. Tag; dass ich mich in diesem Fall unverzüglich an den Arzt wenden oder die nächste Notaufnahme aufsuchen muss; und dass eine Blutung eine erneute Operation, eine Bluttransfusion und selten eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen kann.

☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**

☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.